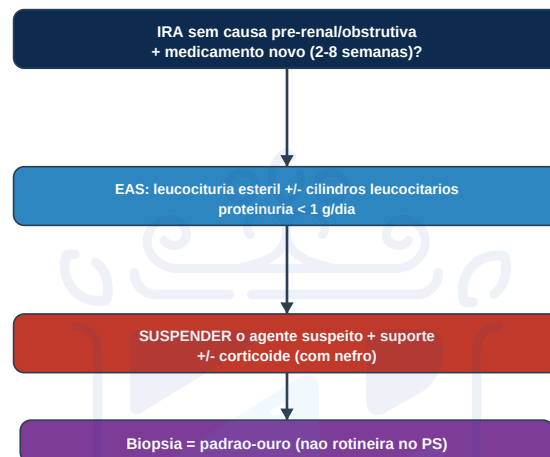


NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA (NIA)

FLUXOGRAMA — IRA SEM CAUSA EVIDENTE

NIA — PENSAR EM IRA + MEDICAMENTO NOVO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Causa de IRA por inflamação do INTERSTÍCIO renal e túbulos, geralmente IMUNOMEDIADA
- Frequentemente associada a MEDICAMENTOS
- Diagnóstico importante e potencialmente REVERSÍVEL de IRA
- Considerar em TODO paciente com IRA sem causa pré-renal ou obstrutiva evidente

CAUSAS

Grupo	Exemplos
Medicamentosa (> 70%)	Antibióticos (betalactâmicos, sulfas, rifampicina), AINEs, INIBIDORES DE BOMBA DE PRÓTONS, diuréticos
Infecções	Bacterianas e virais
Doenças sistêmicas	Sarcoidose, lúpus, Sjögren
Idiopática	Sem causa identificada

QUANDO SUSPEITAR

ANAMNESE E ACHADOS

- Uso recente de novos medicamentos (últimas 2-8 semanas); AINE/IBP crônicos
- Tríade clássica (febre + rash + artralgia) é POUCO frequente — sua ausência NÃO exclui NIA
- Oligúria ou alteração recente do volume urinário
- EAS: LEUCOCITÚRIA ESTÉRIL (sugestiva), CILINDROS LEUCOCITÁRIOS (fortemente sugestivos), proteinúria < 1 g/dia
- Eosinofilia/eosinofílica: baixa sensibilidade e especificidade — ausência não afasta o diagnóstico

EXAMES E DIAGNÓSTICO

INVESTIGAÇÃO

- Creatinina e ureia seriadas; urina I (EAS); proteinúria quantificada
- Hemograma (eosinofilia pode ocorrer); eletrólitos
- USG de rins e vias urinárias (excluir obstrução)
- Diagnóstico é predominantemente CLÍNICO
- Biópsia renal = padrão-ouro, mas NÃO rotineira no PS (indicar se dúvida, falha de recuperação ou IRA grave sem causa)

TRATAMENTO NO PS

Rx O MAIS IMPORTANTE: SUSPENDER O AGENTE

1. SUSPENDER IMEDIATAMENTE o agente suspeito (AINE, antibiótico, IBP, outros)
2. Corrigir distúrbios hidroeletrólíticos; SF 0,9% conforme volemia (evitar sobrecarga)
3. Evitar outros nefrotóxicos; monitorização laboratorial seriada (Cr, ureia, eletrólitos, EAS)
4. CORTICOIDE (com nefrologia): se suspeita clínica forte E persistência da IRA após suspender o agente
Prednisona 0,5-1 mg/kg/dia VO (máx 60 mg/dia), 2-4 semanas com desmame
Iniciar preferencialmente em 7-14 dias do diagnóstico (melhor recuperação renal)

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

INTERNAR SE

- IRA estágio 2 ou 3 (KDIGO)
- Distúrbios hidroeletrólíticos graves (ex.: hipercalemia)
- Oligúria persistente
- Necessidade de biópsia renal
- Impossibilidade de seguimento ambulatorial

CRITÉRIOS DE ALTA

ALTA SE

- ☐ IRA leve e estável
- ☐ Agente causal identificado e SUSPENSO
- ☐ Creatinina em tendência de melhora
- ☐ Acompanhamento nefrológico garantido
- ☐ Orientar o paciente a evitar a reexposição ao agente causal (anotar alergia/intolerância)

MODELO DE ENCAMINHAMENTO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Suspeita de NIA: IRA sem causa pré-renal/obstrutiva + uso recente de ____ (medicamento suspeito).
- EAS: leucocitúria estéril / cilindros leucocitários / proteinúria < 1 g/dia. Creatinina ____.
- Conduta: agente SUSPENSO + suporte; corticoide considerado (com nefrologia).
- Solicito internação/avaliação nefrológica para investigação avançada e eventual biópsia.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com IRA, iniciou omeprazol e ibuprofeno há 3 semanas, EAS com leucocitúria estéril e cilindros leucocitários, proteinúria 0,6 g/dia. Conduta mais importante?

- A) Manter as medicações e observar
- B) Suspender imediatamente os agentes suspeitos e dar suporte, considerando corticoide com nefrologia
- C) Iniciar antibiótico para infecção urinária
- D) Indicar diálise crônica
- E) Aumentar a dose do AINE

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a causa MAIS comum de nefrite intersticial aguda?

- A) Infecciosa
- B) Medicamentosa (> 70%)
- C) Sarcoidose
- D) Lúpus
- E) Idiopática

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado urinário é fortemente sugestivo de NIA?

- A) Cilindros hemáticos
- B) Leucocitúria estéril com cilindros leucocitários e proteinúria < 1 g/dia
- C) Proteinúria maciça (> 3,5 g/dia)
- D) Glicosúria isolada
- E) Cristais de oxalato

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a eosinofilia/eosinofilúria na NIA, é correto:

- A) Sua ausência exclui o diagnóstico
- B) Têm baixa sensibilidade e especificidade; a ausência NÃO afasta NIA
- C) Confirmam o diagnóstico isoladamente
- D) São obrigatórias para o diagnóstico
- E) Indicam glomerulonefrite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando indicar corticoide na NIA?

- A) Em todos os casos, imediatamente
- B) Suspeita clínica forte com persistência da IRA após suspensão do agente, idealmente em 7-14 dias, com nefrologia
- C) Nunca
- D) Apenas após 3 meses
- E) Somente se houver febre

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

IRA com leucocitúria estéril e cilindros leucocitários após início de IBP/AINE é típica de NIA. A medida mais importante é SUSPENDER imediatamente os agentes suspeitos e dar suporte; corticoide se a IRA persistir (com nefrologia).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A causa mais comum de NIA é medicamentosa (> 70%): antibióticos (betalactâmicos, sulfas, rifampicina), AINEs, inibidores de bomba de prótons e diuréticos.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Leucocitúria estéril (sugestiva), cilindros leucocitários (fortemente sugestivos) e proteinúria < 1 g/dia compõem o padrão típico da NIA. Cilindros hemáticos sugerem glomerulonefrite; proteinúria maciça, nefrótica.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Eosinofilia e eosinofilúria têm baixa sensibilidade e especificidade na NIA; sua ausência NÃO exclui o diagnóstico, que é predominantemente clínico (com biópsia como padrão-ouro quando necessária).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O corticoide (prednisona 0,5-1 mg/kg/dia) é indicado na suspeita clínica forte com persistência da IRA após suspender o agente, idealmente iniciado em 7-14 dias para melhor recuperação renal, com a nefrologia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico